KRONOSMEDICINE · CARDIOLOGÍA

Cardiología de un vistazo

20 temas · la perla ENARM de cada uno

1 Hipertensión arterial sistémica

Nunca combines IECA con ARA II. En el embarazo, IECA y ARA II están contraindicados.

2 Crisis hipertensiva

Lo que define la emergencia es el daño agudo a órgano blanco, no la cifra de TA.

3 Angina de pecho

Angina que aparece en reposo, de reciente inicio o en aumento ya no es estable: es un SICA (angina inestable).

4 SICA sin elevación del ST

La trombólisis solo se usa en el SICA CON elevación del ST. En el SEST está contraindicada.

5 SICA con elevación del ST

IAM inferior con hipotensión: piensa en infarto del VD; da volumen y evita nitratos y diuréticos.

6 Riesgo cardiovascular

El tabaquismo es el factor de riesgo modificable cuyo abandono reduce más rápido el riesgo cardiovascular.

7 Cardiopatía isquémica crónica

Diabético con enfermedad de 3 vasos o del tronco: la cirugía de revascularización supera a la angioplastia.

8 Insuficiencia cardiaca crónica

Los diuréticos de asa mejoran síntomas pero no reducen mortalidad; los 4 pilares sí.

9 Insuficiencia cardiaca aguda

En la IC aguda no suspendas el betabloqueador de base salvo choque o bajo gasto grave.

10 Fibrilación auricular

FA con válvula mecánica o estenosis mitral moderada-grave: anticoagular con warfarina, no con anticoagulantes directos.

11 Taquicardia supraventricular

Adenosina: bolo IV rápido seguido de bolo de solución; produce una pausa breve que es esperada.

12 Bloqueo auriculoventricular

Mobitz II y bloqueo AV completo requieren marcapasos definitivo; Mobitz I asintomático no.

13 Síndrome de Wolff-Parkinson-White

FA con QRS ancho e irregular en un joven: piensa en WPW y no des bloqueadores del nodo AV.

14 Endocarditis infecciosa

Profilaxis antibiótica solo en procedimientos dentales de riesgo en pacientes de alto riesgo: prótesis valvular, endocarditis previa y algunas cardiopatías congénitas. Amoxicilina 2 g VO.

15 Pericarditis y derrame pericárdico

Elevación difusa del ST + depresión del PR que mejora al sentarse inclinado: pericarditis, no infarto.

16 Válvula aórtica: estenosis e insuficiencia

Estenosis aórtica grave sintomática: el único tratamiento eficaz es el reemplazo valvular; los fármacos no cambian el pronóstico.

17 Válvula mitral: estenosis e insuficiencia

Soplo diastólico en retumbo con chasquido de apertura en una mujer joven: estenosis mitral reumática.

18 Válvula tricúspide: estenosis e insuficiencia

Los soplos de cavidades derechas aumentan con la inspiración (Rivero-Carvallo).

19 Coartación de la aorta

HTA en joven con pulsos femorales débiles: mide la TA en las 4 extremidades y busca coartación.

20 Disección aórtica

Stanford A = cirugía urgente. Stanford B no complicada = tratamiento médico.